FEDERACION PERUANA DE FUTBOL

CERTIFICADO MEDICO

NOMBF _____

CLUB : _____

MEDICO : DARIO HERNANDEZ _____ CMP: 27503

DOMICILIO: AV CONQUISTADORES 1588 SAN ISIDRO

RTP

QUIEN AL EXAMEN CLINICO PRESENTA:

ARER

AREN

NO SOPLOS

VIAS AEREAS LIBRES

SE ENCUENTRA APTO PARA REALIZAR ACTIVIDAD DEPORTIVA (FUTBOL)

FIRMA Y SELLO DEL MEDICO

FECHA

NUMERO DE RECIBO : _____

@FAMIHEARTSAC

EVALUACIÓN MÉDICA

PRE-COMPETENCIA

APELLIDOS

NOMBRES

FECHA DE NACIMIENTO

POSICIÓN JUGADOR/A

CLUB LOCAL / SELECCION

PAIS DEL CLUB

Famiheart

Famiheartsac

HISTORIA CLÍNICA PRE-PARTICIPATIVA

General – Cardiovascular

Historia Cardiológica Personal	SI
Dolor o malestar toráxico de esfuerzo.	
Lipotimia o sincope no explicado.	
Disnea o fatiga desproporcionada en esfuerzo.	
Soplo cardiaco previo.	
Antecedente de hipertensión arterial.	
Restricción previa para participar en deporte.	

Historia Cardiológica Familiar	SI
Muerte súbita cardiaca de familiar menor de 50 años.	
Enfermedad coronaria en familiar menor de 50 años.	
Familiares con patología cardiaca con riesgo de muerte súbita.	

Historia Cardiológica General	SI
Cirugías no traumatológicas.	
Hospitalizaciones no quirúrgicas.	
Traumatismo Cráneo Encefálico.	
Asma Bronquial.	
Otra patología relevante (ej. Epilepsia, diabetes, hipotiroidismo, etc.)	

HISTORIA CLÍNICA PRE-PARTICIPATIVA

General – Cardiovascular

Fármacos de Uso Habitual	DOSIS	DIAGNÓSTICO
.		
2.		
3.		

Suplementos de Uso Habitual	DOSIS	INDICACIÓN
.		
2.		
3.		

HISTORIA CLÍNICA PRE-PARTICIPATIVA

Sistema Músculo – Esquelético

Operaciones	DERECHA	IZQUIERDA	FECHA
Hombro			
Codo			
Mano			
Columna			
Cadera			
Pubis			
Rodilla – Ligamento			
Rodilla – Meniscos			
Muslo			
Tobillo			
Pie			
Tendón Aquiles			
Otra			

Lesión Grave *Inactividad igual/mayor a 4 semanas	DERECHA	IZC	A
Hombro			
Codo			
Mano			
Columna			
Cadera			
Pubis			
Rodilla – Ligamento			

Rodilla – Meniscos	
Muslo	
Tobillo	
Pie	
Tendón Aquiles	
Otra	

Para jugadoras

Ciclo Menstrual Regular	SI	NO
Dismenorrea	NO	Si, en las últimas 4 semanas. Sí, antes de las últimas 4 semanas.
¿Está embarazada la jugadora?	NO	SI, ¿Desde cuándo?
¿Recurre la jugadora a métodos hormonales para suprimir o retardar la menstruación durante competiciones importante?	SI	NO

Patología

	AGUDA	CRÓNICA	DIAGNOSTICO
Hombro			
Codo			
Mano			
Columna			
Cadera			
Pubis			
Rodilla – Ligamento			

Rodilla – Meniscos			
Muslo			
Tobillo			
Pie			
Tendón Aquiles			
Otra			

EXAMEN FÍSICO PRE-PARTICIPATIVA

PESO: TALLA: IMC:

Patología

GENERAL	NORMAL	ANORMAL	DESCRIPCIÓN
Pulso			
Presión Arterial (Sentado)			
Cabeza			
Cuello			
Tórax: Corazón			
Pulmonar			
Abdomen			

MUSCULOESQUELÉTICO	ANORMAL	DI	ÓN
Columna			
Codo – Mano			
Columna			
Cadera – Ingle			
Muslo			
Rodilla			
Pierna			

ELECTROCARDIOGRAMA DE REPOSO

NORMAL | | NO

Hallazgo Tipo 1 (Normales en deportistas)	SI	NO
Bradicardia Sinusal.		
Bloqueo AV 1°.		
Bloqueo incompleto de rama derecha.		
Hipertrofia ventricular izquierda por criterio de voltaje.		
Repolarización precoz.		
ST Elevado con T negativa V1 – V4 en raza negra		
ST Elevado con T negativa V1 -V3 en menores 16 años		
Ectopia atrial o ritmo de la unión.		
Bloqueo AV 2° Tipo Mobitz 1.		

Hallazgos limítrofes (se acepta solo 1 ítem)	SI
Eje eléctrico desviado a Izquierda.	
Eje eléctrico desviado a Derecha.	
Crecimiento Aurícula Izquierda.	
Crecimiento Aurícula Derecha.	
Bloqueo completo Rama Derecha.	

Hallazgos Tipo 2 (Anormales en deportistas)	SI
Onda T invertida más allá de V4 en raza negra y V3 en raza blanca.	
ST con depresión	
Onda Q patológica	
Bloqueo completo de rama izquierda	
QRS > 140	

COMISIÓN MÉDICA
CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE FÚTBOL

	SI	NO
a epsilón		
QTC prolongado		
Brugada Tipo 1		
Bradicardia Sinusal > 30 lpm		
Intervalo PR > 40 MSG		
Bloqueo 2° Monitz tipo 2		
Bloqueo AV Completo (3°)		
Extrasístoles ventriculares (>2)		
Taquiarritmias auriculares		
Arritmias ventriculares		

DARIO HERNANDEZ ALARCON
C.M.P 27503 RNE 15620
CARDIOLOGIA

ELECTROCARDIOGRAMA Y DOPPLER CARDIACO

Mediciones Modo M-2D y Doppler		COMENTARIO
Raiz de aorta	Mm	
Aorta Ascendente	Mm	
Aurícula izquierda (diámetro eje largo)	Mm	
Aurícula izquierda área 4 cámaras	ms2	
Aurícula izquierda volumen auricular	l/m2	
Aurícula derecha área en 4 cámaras	Mm	
Ventrículo izquierdo diámetro interno diastólico	Mm	
Septum interventricular diastólico	Mm	
Pared posterior diastólico	%/%	
Fracción eyección/ Fracción acortamiento		
Motilidad segmentaria (Normal o Anormal)	Mm	
Ventrículo derecho diámetro basal 4 cámaras		
Válvula Mitral (normal / anormal)		
Válvula Aórtica (normal / anormal)		

Válvula Tricúspide (normal / anormal)		
Válvula Pulmonar (normal / anormal)		mmHg
Presión Sistólica Arteria Pulmonar		
E/E' medial		
E/E' Lateral		
Strain rate longitudinal ventrículo izquierdo 4 cámaras*		
Strain rate longitudinal ventrículo izquierdo 3 cámaras*		
Strain rate longitudinal ventrículo izquierdo 2 cámaras*		

CONCLUSIONES

1.
2.
3.
4.
5.

DARIO HERNANDEZ ALARCON
C.M.P 27503 RNE 15620
CARDIOLOGIA

IÓN MÉDICA
RICANA DE FÚTBOL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SANGRE

(En ayunas)

Hemoglobina	
Hematócrito	
Eritrócitos	
Trombocitos	
Leucócitos	
Sódio	
Potasio	
Calcio	
Fósforo	
Creatinina	
Colesterol (total)	
Colesterol LDL	
Colesterol HDL	
Triglicéridos	
Proteína C-reativa	
Ferritina	

COMISIÓN MÉDICA

CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE FÚTBOL

RESUMEN DE LA EVALUACION PRE-PARTICIPATIVA

HISTORIA CLINICA	NORMAL	ANORMAL
Examen Físico General		
Examen Físico Ortopédico		
Laboratorio Clínico		

ELECTROCARDIOGRAMA DE REPOSO	NORMAL	ANORMAL
Normal		
Hallazgo Tipo 1 (Frecuente en deportista)		
Hallazgo Intermedio (1)		
Hallazgo Intermedio (2 o +)		
Hallazgo Tipo 2 (Anormal)		

ECOCARDIOGRAMA Y DOPPLER CARDIACO	NORMAL	ANORMAL
Normal		
Compatible corazón atleta		
Anormal		

CONCLUSIONES

Apto

Apto

No apto

MÉDICO INSTITUCIÓN:

DARIO HERNANDEZ

INSTITUCIÓN REALIZADA LA INFORMACIÓN:

FAMIHEART

FIRMA:

DARIO HERNANDEZ ALARCON
C.M.P 27503 RNE 15620
CARDIOLOGIA

MÉDICO REVISADOR COMISIÓN MÉDICA - CONMEBOL:

FECHA:

FIRMA:

El médi

paciente _____

Rx

electrocardiograma y ecocardiografía, los cuales se encuentran dentro de los límites normales y siendo asintomático cardiovascular, sin antecedentes, se encuentra apto para realizar actividad física sin restricciones.

Atte.

_____

DARIO HERNANDEZ ALARCON
C.M.P 27503 RNE 15620
CARDIOLOGIA

INFORME ECOCARDIOGRAFICO

Nombre
Fecha : _____

1 MEDICIONES: **NORMAL**

Ventrículo derecho _____ _____ mm (0.8 – 2.7)
Septum Interventricular ____ _____ mm (8 – 11)
V.I Diástole _____ _____ mm (35 – 57)
V.I sístole _____ _____ mm ( )
Pared Posterior V.I_____ _____mm (6 – 11)
Aurícula Izquierda _____ _____mm (22 – 40)

NORMAL

Aorta Raiz_____mm (2.2 – 3.6)
Aorta apertura _ _ mm (15 – 26)
Tracto de Salida VI _____mm ( )
V Mitral Exclusión _____ mm (20 – 30)
V Mitral Pendiente _____ Mseg
Pendiente E – S _____ ____ ( )

2 FUNCION CARDIACA: **NORMAL**

Fracción de Eyección _____ ____ % (55 – 80)
Fracción de Acortamiento _____ % (30 – 48)
Volumen sistólico _____%
Gasto Cardiaco _____ L/m
Índice cardiaco _____ L/m/m2

NORMAL

Onda E (mitral) _____ __cm/s
Onda A (mitral) _____ ____cm/s
Relación E/A _____
Tiempo de relajación Isov_____
Tac Pulmonar_____

3 EVALUACION VALVULAR (DOPPLER)

Mitral diastos Gradiente Max _____ Gradiente Medio _____ THP _____ área Mitral____
Aortica sístole Gradiente Max _____ Gradiente Medio _____ VMXTSVI ____ área Aortica ____
Aortica Diástole THP _____ Pendiente _____ Área regurgitación _____
TRICUSPIDEA sístole Gradiente VD – AD _____ Presión Sistólica AP _____mmhg
PULMONAR sístole VD - AP_____

4 INTERPRETACION:

CAVIDADES CARDIACAS: NORMAL
GROSOR DEL MIOCAARDIO: NORMAL
VALVULAS CARDIACAS: COMPETENTES
PADRON CONTRACTIL VENT. IZQ GLOBAL_: CONSREVADO
SEGMENTAR : LIBRE__
TRACTO DE SALIDA DEL VENTRICULO: CONSERVADO
EL DOPPLER MUESTRA: E > A
ARTERIAS AORTA: CONSERVADO ____ PULMONAR: CONSERVADO____
PERICARDIO: NO DERRAME
FUNCION DEL VENTRICULO IZQUIERDO: CONSERVADO

DARIO HERNANDEZ ALARCON
C.M.P 27503 RNE 15620
CARDIOLOGIA

5 CONCLUSIONES:

- **FUNCION SISTOLICA DE VI CONSERVADA.**
- **CAVIDADES CARDIACAS DENTRO DE LIMITES NORMALES**
- **NO SIGNO DE HTP**
- **PERICARDIO LIBRE, NO DERRAME**
- **ECOCARDIOGRAFIA EN REPOSO DENTRO DE LÍMITES NORMALES.**
- **APTO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS SIN RESTRICCIONES**

[ESPACIO PARA ADJUNTAR ECOCARDIOGRAMA 2D / DOPPLER]

[ESPACIO PARA ADJUNTAR ECOCARDIOGRAMA M-MODE / FLUJOS]

ELECTROCARDIOGRAMA DE REPOSO (12 DERIVACIONES) - FAMIHEART S.A.C.

[ESPACIO OFICIAL PARA ADJUNTAR EL TRAZADO ELECTROCARDIOGRAFICO]

Estandar: 25 mm/s - 10 mm/mV - Filtro 50/60 Hz - 12 Derivaciones

PACIENTE
MEDICO: _____ **SE**

FECH

HEMOGRAMA COMPLETO

ANALISIS	RESULTADO	UND	RAN
Recuento de Globulos Rojos		/mm³	3'800,000 - 5'800,000
Hemoglobina		gr%	Hombre: 13.0 -16.0
			Mujer : 12.0 - 14.0
Hematocrito		%	Hombre : 40 - 54
			Mujer : 35 - 47
Leucocitos		/mm³	Adulto : 4,500 -10,000
			Niño : 8,000 - 11,000
Recuento de Plaquetas		/mm³	150,000 - 450,000
VCM		fl	80 -97
HCM		pg	27 - 32
CHCM		grHb/dl	30 - 35
FORMULA DIFERENCIAL PORCENTUAL			
Linfocitos		%	25 - 40
Monocitos		%	2 - 6
Eosinofilos		%	2 - 4
Basofilos		%	0 - 1
Segmentados		%	50 - 70
Abastonados		%	2 - 5

LISBETT SUSAN HILARES MOSCOSO
TEGNOLOGO MEDICO
C.T.M.P 8355

Famiheart Famiheartsac

PACIENTE
MEDICO:

RESULTADO

SEXO

BIOQUIMICA

ANALISIS	RESULTADO	UND	RANGO REFERENCIAL
GLUCOSABASAL		mg/dl	70 - 110

LISBETT SUSAN HILARES MOSCOSO
TEGNOLOGO MEDICO
C.T.M.P 8355

Famiheart Famiheartsac

PACIENTE
MEDICO:

PARASITOLOGICO SERIADO

FECHA

SEXO:

COLOR
CONSISTENCIA
PARASITOS
MUCOSIDAD
OTROS

LISBETT SUSAN HILARES MOSCOSO
TEGNOLOGO MEDICO
C.T.M.P 8355

RADIOGRAFIA DE TORAX

NOM _____

FECHA _____

DESCRIPCION RADIOLOGICA:

La radiografía de tórax en incidencia PA, muestra:

1. Transparencia pulmonar conservada en ambos campos pulmonares
2. Senos costo diafragmáticos libres
3. Índice cardiotorácico dentro de límites normales
4. Partes blandas adyacentes conservadas

CONCLUSION:

Estudio radiográfico dentro de límites normales

JORGE VERA PONCE DE LEON
MEDICO RADIOLOGO - ECOGRAFISTA
CMP 29129 -RNE: 2986

@FAMIHEARTSAC

SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)

[ESPACIO OFICIAL PARA ADJUNTAR LA PLACA RADIOGRAFICA DE TORAX]

Incidencia Postero-Anterior (PA) - Campo Pleuropulmonar y Silueta Cardiaca